

《2016 年欧洲心脏病学会/欧洲动脉粥样硬化化学会血脂异常管理指南》解读

陈涛 袁祖貽

【关键词】 血脂异常; 指南解读

【中图分类号】 R589.2

2016 年 8 月, 欧洲心脏病学会 (European Society of Cardiology, ESC) 和欧洲动脉粥样硬化化学会 (European Atherosclerosis Society, EAS) 联合发布了欧洲血脂异常管理指南 (以下简称《2016 年指南》)^[1]。《2016 年指南》以《2011 年 ESC/EAS 血脂异常管理指南》(以下简称《2011 年指南》)^[2] 为基础, 并结合最近 5 年的众多循证证据结果做出相应修订。总体上, 《2016 年指南》对血脂异常总的管理原则与既往指南一致, 有以下几点特点。

1 坚持总体的心血管风险评估, 扩大风险评估及极高危人群范畴

《2016 年指南》继续强调评价患者整体心血管风险, 强调生活方式改良是管理血脂异常的核心策略。对于年龄 > 40 岁的无心血管病、糖尿病、慢性肾病或家族性高胆固醇血症证据的无症状成年人, 建议应用诸如 SCORE 等风险评估系统评估总体心血管风险 (I, C)。SCORE 风险评估基于年龄、性别、吸烟情况、收缩压和总胆固醇水平, 系统评价了首次发生致死性动脉粥样硬化事件 (包括心脏病、卒中或其他闭塞性动脉疾病) 的 10 年累积风险。根据评估结果, 《2016 年指南》保留了《2011 年指南》的极高危、高危、中危和低危四个危险分层。为了保证评估结果的准确性, 针对比较年轻的患者, 《2016 年指南》增加了危险年龄和终身风险两个指标, 对这类患者进行准确风险评估, 还对不同的危险组群设立了相应的靶标值, 这使得临床治疗有章可循。

在《2011 年指南》对极高危患者界定的基础上, 《2016 年指南》将高危人群范畴进一步扩大。《2011 年指南》中, 极高危心血管病风险的患者包括: (1) 经侵入性或非侵入性检查确诊的心血管疾病患者; (2) 既往心肌梗死、急性冠状动脉综合征 (acute coronary syndrome, ACS)、冠状动脉血运重建 经皮冠状动脉介入治疗 (percutaneous coronary intervention, PCI) 和冠状动脉旁路移植术 (coronary artery bypass grafting, CABG) 患者, 以及其他动脉血运重建手术、缺血性卒中和周围血管病变患者; (3) 有靶器官损害 (如微量白蛋白尿) 的 2 型和 1 型糖尿病患者、中重度慢性肾病患者、10 年风险 SCORE 评分 ≥ 10 分患者。《2016 年指南》中, 极高危人群在上述基础上进一步扩大, 将冠状动脉造影或颈动脉超声检查发现斑块的患者、短暂性脑缺血发作的患者也纳入了极高危人群的范畴。

2 坚持低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 是核心靶目标, 强调越低越好的管理理念 (表 1)

《2016 年指南》强调低密度脂蛋白胆固醇 (LDL-C) 达标是血脂管理的核心靶目标, 并保留了 LDL-C 目标值, 建议 LDL-C 作为首选治疗靶目标 (I, A)。与《2011 年指南》及《2013 年美国心脏病学院/美国心脏协会血胆固醇治疗指南》^[3] 相比, 《2016 年指南》强调要进一步严格控制胆固醇水平, 建议控制的靶目标甚至比美国指南更严格。极高危及高危人群的 LDL-C 控制目标分别为 < 1.8 mmol/L 和 < 2.6 mmol/L, 中低危人群的 LDL-C 控制目标为 < 3.0 mmol/L。若患者血脂水平不是特别高, 如极高危患者的 LDL-C 为 1.8 ~ 3.5 mmol/L, 指南要求至少应将其 LDL-C 水平降低

表 1 ESC/EAS 血脂异常管理指南建议的 LDL-C 治疗目标值

危险分层	2011 年 ESC/EAS 血脂异常管理指南	2016 年 ESC/EAS 血脂异常管理指南
极高危	<1.8 mmol/L (70 mg/dl) , 如未能达标建议将 LDL-C 降低 ≥50% (I , A)	<1.8 mmol/L (70 mg/dl) , 如基线 LDL-C 1.8 ~ 3.5 mmol/L (70 ~ 135 mg/dl) , 建议将 LDL-C 降低 ≥50% (I , B)
高危	<2.5 mmol/L (100 mg/dl) (II a , A)	<2.6 mmol/L (100 mg/dl) , 如基线 LDL-C 2.6 ~ 5.2 mmol/L (100 ~ 200 mg/dl) , 建议将 LDL-C 降低 ≥50% (I , B)
中危	<3.0 mmol/L (115 mg/dl) (II a , C)	<3.0 mmol/L (115 mg/dl) (II a , C)
低危	未建议	<3.0 mmol/L (115 mg/dl) (II a , C)

注: LDL-C, 低密度脂蛋白胆固醇; ESC, 欧洲心脏病学会; EAS, 欧洲动脉粥样硬化学会

50% , 这就意味着若患者基线 LDL-C 水平为 3.0 mmol/L , 需要将 LDL-C 水平至少降至 1.5 mmol/L 。对中低危人群分别提出了相应的 LDL-C 目标值,同时对于基线胆固醇水平较低患者,建议将 LDL-C 降低 50% 作为治疗目标,以指导 LDL-C 接近目标值时的降脂治疗策略。LDL-C 控制更加严格,保留 LDL-C 目标值的原因: (1) 总体心血管风险降低需要个体化,确定靶目标可使个体化治疗更明确; (2) 靶目标可帮助患者与医师沟通; (3) 靶目标有助于提高治疗依从性。

另外,《2016 年指南》简化了血脂检测手段。这是一个新的大突破,建议测量血脂时不一定非要空腹,空腹及非空腹测量均可。这是因为两种方法对血样进行测定时所得出的总胆固醇、LDL-C、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) 结果并无明显差别,且这两种方法所测定的数据对心血管风险评估的价值也并无太大差别。这一建议无疑大大简化了血脂测量的过程,使血脂测量更方便,便于对患者进行筛查和随访。但一项研究显示,糖尿病患者非空腹血脂较空腹时低 0.6 mmol/L ,可能造成低估糖尿病患者的风险^[4]。另外,三酰甘油(TG) 易受饮食影响,建议高甘油三酯血症患者评估应空腹测量。

3 坚持他汀一线基石地位,强调长期治疗的必要性

与《2011 年指南》相比,《2016 年指南》对于调脂药物的建议并无明显改变,但有一些细微差异。他汀作为唯一一线用药的建议并未改变,所有血脂异常患者尤其是高胆固醇血症患者都应首选他汀类药物进行降脂治疗(I , A)。

其他降脂类药物仅仅是对他汀治疗的一个补充。《2016 年指南》所建议的二线药物与既往指南相比有了一定的变化。一方面,鉴于近年来两项研究显示,在他汀基础上加用烟酸类药物不能为患者带来获益^[5-6],欧洲也已经不允许烟酸类药物上市,故《2016 年指南》在二线药物建议中去掉了烟酸类

药物,而将一些新药如前蛋白转化酶枯草溶菌素 9 (PCSK9) 抑制药纳入到了二线及三线药物建议中。

《2016 年指南》肯定了 PCSK9 抑制药的降脂效果,但因缺乏大规模随机临床试验,目前建议其用于治疗难治性及未耐受他汀治疗的患者,以及家族性高胆固醇血症患者。对胆固醇吸收抑制剂依折麦布,《2011 年指南》已经建议其可作为二线药物用于治疗他汀不能耐受的患者或他汀足剂量治疗后未达标的患者。《2016 年指南》仍然维持《2011 年指南》有关依折麦布可作为他汀治疗二线补充的建议。根据患者的具体情况,在他汀治疗后不能达标时作为补充或者患者不耐受他汀治疗时进行替代,但绝大部分患者可以耐受他汀治疗。虽然患者的危险分层不同,血脂控制的靶目标可能有所不同,但都应首先进行他汀治疗,并尽可能用到最大建议剂量或最大耐受剂量。只有在上述前提下,才可以考虑是否需要追加第二种或第三种药物。因此,《2016 年指南》建议降脂治疗应选择强效他汀并应用至最大建议剂量或最大耐受剂量,而且是 I 类建议 A 级证据;而他汀基础上加用依折麦布的建议级别则仅为 II a ,证据水平也只是 B 级。所以,对于绝大多数需要降脂治疗的患者,首先应选择他汀治疗并尽量应用到最大耐受剂量,若仍未达标才考虑加用依折麦布。

4 坚持 ACS 患者强化他汀治疗,强调他汀早期、长期坚持治疗(表 2)

《2016 年指南》指出,ACS 患者除了全面控制心血管病危险因素(包括生活方式干预、危险因素管理和部分患者应用心脏保护药物) 之外,无论患者的基线 LDL-C 水平如何,都需早期、在住院后 1 ~ 4 d 内常规启动高强度他汀治疗(I , A) ,目标是使 LDL-C 降到 <1.8 mmol/L (70 mg/dl) 或使 LDL-C 至少降低 50% (基线 LDL-C 为 1.8 ~ 3.5 mmol/L) 。仅在高强度他汀治疗增加不良反应风险的人群(如

表 2 《2016 年 ESC/EAS 血脂异常管理指南》对 ACS 和 PCI 术后患者 LDL-C 治疗的建议

建议	建议级别	证据等级
对于无禁忌证或他汀不耐受的 ACS 患者,无论基线 LDL-C 水平如何,入院后均建议尽早启动或继续高剂量他汀治疗	I	A
对于最大耐受剂量他汀治疗后 LDL-C 仍未达标的 ACS 患者,应考虑联合使用他汀与依折麦布	II a	B
对于最大耐受剂量他汀和(或)依折麦布治疗后 LDL-C 仍未达标的患者,可考虑加用 PCSK9 抑制药;对于他汀不耐受或禁忌使用他汀的患者,PCSK9 抑制药可单用或与依折麦布联用	II b	C
ACS 后 4~6 周应重新评估血脂,确定 LDL-C 是否 <1.8 mmol/L 或基线 LDL-C 1.8~3.5 mmol/L(70~135 mg/dl) LDL-C 降低是否 ≥50%,以及有无安全性问题。应据此进行相应的剂量调整	II a	C
对于择期 PCI 或非 ST 段抬高 ACS 患者,应考虑 PCI 术前高剂量他汀常规短期预处理或负荷剂量治疗(长期治疗基础上)	II a	A

注:ESC,欧洲心脏病学会;EAS,欧洲动脉粥样硬化学会;ACS,急性冠状动脉综合征;PCI,经皮冠状动脉介入治疗;LDL-C,低密度脂蛋白胆固醇;PCSK9,前蛋白转化酶枯草溶菌素 9

老年人、肝功能损伤、肾功能损伤或可能与必须的合并治疗产生相互作用的患者),才考虑更低强度的他汀治疗。仍然强调在他汀治疗干预4~6周后要检测血脂水平并调整治疗策略(血脂达标及安全性)。

《2016 年指南》基于最近 5 年的众多循证证据,对血脂管理建议进行了更新,简化明确的建议对临床实践具有重要指导价值。该指南可能对我国未来指南或专家共识的制定具有借鉴作用。我们需要深思并讨论如何将中国证据与国际指南更好结合以指导中国临床实践。

参 考 文 献

[1] Catapano AL,Graham I, De Backer G, et al. 2016 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: The task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and European Atherosclerosis Society (EAS)

developed with the special contribution of the European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation (EACPR). Eur Heart J, 2016. [Epub ahead of print]

[2] Reiner Z, Catapano AL, De Backer G, et al. ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: the task force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur Heart J, 2011,32(14):1769-1818.

[3] Stone NJ,Robinson JG, Lichtenstein AH, et al. 2013 ACC/AHA guideline on the treatment of blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: a report of the American College of Cardiology/American Heart Association task force on practice guidelines. J Am Coll Cardiol, 2014,63(25 Pt B):2889-2934.

[4] Langsted A,Nordestgaard BG. Nonfasting lipids, lipoproteins, and apolipoproteins in individuals with and without diabetes: 58 434 individuals from the copenhagen general population study. Clin Chem, 2011,57(3):482-489.

[5] Boden WE,Probstfield JL, Anderson T, et al. Niacin in patients with low HDL cholesterol levels receiving intensive statin therapy. N Engl J Med, 2011,365(24):2255-2267.

[6] Landray MJ,Haynes R, Hopewell JC, et al. Effects of extended-release niacin with laropiprant in high-risk patients. N Engl J Med,2014,371(3):203-212.

(收稿日期:2016-09-27)

· 读者 · 作者 · 编者 ·

关于医学论文中的作者署名

我国著作权法公布以来,已得到社会各界的广泛重视,作为医学科技期刊必须严格执行著作权法。为此,本刊对作者署名的有关要求重申如下。

作者署名的意义和应具备的条件:

(1) 署名的意义:①标明论文的责任人,文责自负;②医学论文是医学科技成果的总结和记录,是作者辛勤劳动的成果和创造智慧的结晶,也是作者对医学事业作出的贡献,并以此获得社会的尊重和承认的客观指标,是应得的荣誉,也是论文版权归作者的一个声明;③作者署名便于编辑、读者与作者联系,沟通信息,互相探讨,共同提高。作者姓名在文题下按序排列,排序应在投稿时确定,在编排过程中不应再作更改。作者单位名称及邮政编码脚注于同页左下方。

(2) 作者应具备下列条件:①参与选题和设计,或参与资料的分析和解释者;②起草或修改论文中关键性理论或其他主要内容者;③能对编辑部的修改意见进行核修,在学术

界进行答辩,并最终同意该文发表者。以上 3 条均需具备。仅参与获得资金或收集资料者不能列为作者,仅对科研小组进行一般管理者也不宜列为作者。其他对该研究有贡献者应列入志谢部分。对文章中的各主要结论,均必须至少有 1 位作者负责。在每篇文章的作者中需要确定 1 位能对该论文全面负责的通信作者。通信作者应在投稿时确定,如在来稿中未特殊标明,则视为第一作者为通信作者。第一作者与通信作者不是同一人时,在论文首页脚注通信作者姓名和邮箱。作者中如有外籍作者,应附本人亲笔签名同意在本刊发表的函件。集体署名的论文于文题下列署名单位,与文末列整理者姓名,并于论文首页脚注通信作者姓名和邮箱。集体署名的文章必须将对该文负责的关键人物列为通信作者。通信作者只列 1 位,由投稿者决定。

本刊编辑部